TSIFRA, LDA.
Revista de Investigação Interdisciplinar (Demo)
Vol. 1, n.º 2 (2025)
pp. 11–13 · ISSN 0000-0000 (em linha)

ARTIGO DE INVESTIGAÇÃO

Adesão à telemedicina por pessoas idosas em pequenas cidades: um estudo de métodos mistos

Olga Vasilenko[1], **Miroslav Jovanović**[2✉], **Natalia Arkadyeva**[1]

[1] Instituto de Investigação em Saúde Pública Vita, Rússia
[2] Centro do Danúbio de Investigação em Saúde da População, Sérvia
✉ Autor correspondente: Miroslav Jovanović, m.jovanovic@example.org

Recebido: 4 de março de 2025 **Aceite:** 15 de julho de 2025 **Publicado:** 25 de setembro de 2025

RESUMO

As teleconsultas podem melhorar o acesso aos cuidados de saúde dos residentes idosos das pequenas cidades, onde a escassez de médicos especialistas é particularmente aguda. No entanto, a adesão das pessoas idosas a estes serviços continua baixa e as suas razões não são suficientemente conhecidas. Este estudo de métodos mistos analisa os fatores associados à utilização da telemedicina por pessoas com 60 ou mais anos em quatro pequenas cidades anonimizadas. A fase quantitativa consistiu num inquérito telefónico a 812 inquiridos; a fase qualitativa consistiu em 28 entrevistas semiestruturadas a doentes e 9 entrevistas a profissionais de saúde. No último ano, 19% dos inquiridos tinham utilizado serviços de telemedicina. Num modelo logístico multivariável, a probabilidade de utilização esteve associada à posse de smartphone, à coabitação com familiares mais jovens e à existência de doenças crónicas que exigem monitorização regular, ao passo que a associação com a idade se atenuou após o ajustamento para estes fatores. As entrevistas revelaram três barreiras principais: a desconfiança relativamente à avaliação do estado de saúde à distância, a complexidade dos procedimentos de marcação e de autenticação e o receio de fazer o médico perder tempo sem uma consulta presencial. Os profissionais de saúde salientaram que a telemedicina é mais útil para consultas de seguimento e para o ajuste do tratamento. Concluímos que interfaces simplificadas e o apoio de enfermeiros poderiam alargar substancialmente a utilização da telemedicina pelas pessoas idosas.

Palavras-chave: telemedicina; pessoas idosas; pequenas cidades; fosso digital; métodos mistos

Telemedicine Uptake among Older Adults in Small Towns: A Mixed-Methods Study

Olga Vasilenko[1], *Miroslav Jovanović*[2✉], *Natalia Arkadyeva*[1]

[1] Vita Research Institute of Public Health, Russia
[2] Danube Centre for Population Health Research, Serbia

ABSTRACT

Telemedicine consultations can improve access to healthcare for older residents of small towns, where the shortage of specialist physicians is particularly acute. However, uptake of such services among older people remains low, and the reasons are insufficiently understood. This mixed-methods study analyses the factors associated with telemedicine use among people aged 60 and over in four anonymised small towns. The quantitative phase comprised a telephone survey of 812 respondents; the qualitative phase consisted of 28 semi-structured interviews with patients and 9 interviews with healthcare workers. Over the past year, 19% of respondents had used telemedicine services. In a multivariable logistic model, the probability of use was associated with smartphone ownership, living with younger relatives and having chronic conditions requiring regular monitoring, whereas the association with age weakened after adjustment for these factors. Interviews revealed three key barriers: distrust of remote assessment of health status, complex booking and authentication procedures, and a fear of wasting the doctor's time without an in-person visit. Healthcare workers noted that telemedicine is most valuable for follow-up consultations and adjusting treatment. We conclude that simplified interfaces and support from nurses could substantially broaden telemedicine use among older adults.

Keywords: telemedicine; older adults; small towns; digital divide; mixed methods

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0

Como citar: Vasilenko O., Jovanović M., Arkadyeva N. Adesão à telemedicina por pessoas idosas em pequenas cidades: um estudo de métodos mistos. *Revista de demonstração em Open Journal Systems* 2025;1(2):11–13.

1 INTRODUÇÃO

As pequenas cidades enfrentam uma escassez persistente de médicos especialistas, e os residentes idosos têm muitas vezes de se deslocar a centros regionais para as consultas. A telemedicina, sob a forma de consultas médicas por vídeo ou por telefone, tem sido promovida como forma de colmatar esta lacuna, e a infraestrutura de teleconsultas expandiu-se consideravelmente após 2020.

Apesar disso, as pessoas idosas, que mais poderiam beneficiar, utilizam a telemedicina menos do que os outros grupos etários. As explicações centram-se habitualmente nas competências digitais, mas tem sido dada menos atenção às atitudes, às circunstâncias do agregado familiar e à organização dos serviços. Este estudo combina dados de inquérito e entrevistas para traçar um quadro mais completo da adesão à telemedicina entre os residentes idosos das pequenas cidades.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A fase quantitativa consistiu num inquérito telefónico assistido por computador, realizado em março–maio de 2024 em quatro cidades com 18 000–45 000 habitantes (codificadas T1–T4). Uma amostra aleatória de números de telefone fixo e móvel resultou em 812 entrevistas completas a residentes com 60 ou mais anos (taxa de resposta de 37%). A utilização da telemedicina nos últimos 12 meses foi a variável de resultado principal; as covariáveis incluíram características demográficas, estado de saúde, posse de dispositivos e composição do agregado familiar.

Na fase qualitativa, 28 participantes no inquérito (14 utilizadores e 14 não utilizadores) e 9 profissionais de saúde participaram em entrevistas semiestruturadas. As transcrições foram objeto de análise temática por dois investigadores de forma independente, sendo as divergências resolvidas por discussão.

3 RESULTADOS

No total, 19% dos inquiridos declararam pelo menos uma teleconsulta no último ano. A adesão foi mais elevada entre as pessoas com doenças crónicas que exigem acompanhamento regular (27%) e mais baixa entre as que vivem sozinhas sem smartphone (6%) (fig. 1).

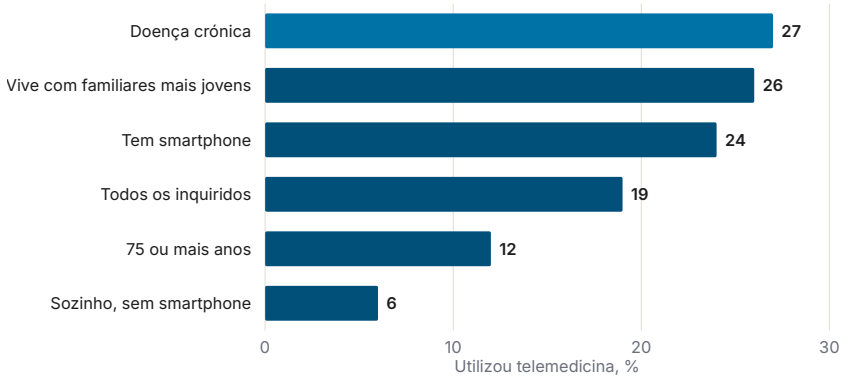


Fig. 1. Utilização da telemedicina nos últimos 12 meses por grupo de inquiridos, %

O quadro 1 apresenta os odds ratios ajustados. A posse de smartphone mais do que triplicava a probabilidade de utilização, e a coabitação com familiares mais jovens duplicava-a. O efeito da idade atenuou-se e perdeu significância estatística após o ajustamento para a posse de dispositivos e a composição do agregado familiar.

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0

Quadro 1. Fatores associados à utilização da telemedicina (regressão logística, n = 812)

Fator	OR ajustado	IC 95%	p
Tem smartphone	3.4	2.1–5.5	<0.001
Vive com familiares mais jovens	2.0	1.3–3.0	0.001
Doença crónica, monitorização regular	1.8	1.2–2.7	0.004
Idade (por 5 anos)	0.89	0.76–1.04	0.140
Sexo feminino	1.1	0.8–1.6	0.520

4 DISCUSSÃO

As entrevistas ajudaram a interpretar estas associações. Os familiares mais jovens atuavam frequentemente como intermediários, marcando as consultas e configurando os dispositivos. Os não utilizadores manifestavam muitas vezes dúvidas de que um médico pudesse avaliar o seu estado sem os examinar, e vários referiram sentir que uma teleconsulta seria um fardo para um médico já sobrecarregado.

Os profissionais de saúde consideraram a telemedicina mais útil para consultas de seguimento e ajustes da medicação, e sugeriram que os enfermeiros poderiam ajudar os doentes a estabelecer a ligação a partir do centro de saúde ou em casa. Estes resultados apontam para soluções organizacionais, e não puramente tecnológicas.

5 CONCLUSÃO

A adesão à telemedicina por pessoas idosas em pequenas cidades é limitada menos pela idade em si do que pelo acesso a dispositivos, pelo apoio do agregado familiar e pela confiança. Procedimentos de marcação simplificados e teleconsultas facilitadas por enfermeiros são vias promissoras para alargar a sua utilização.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Creswell J. W., Plano Clark V. L. Designing and Conducting Mixed Methods Research. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE, 2017. 492 p.
2. Braun V., Clarke V. Using thematic analysis in psychology // Qualitative Research in Psychology. 2006. Vol. 3, no. 2. P. 77–101.
3. Vasilenko O. P., Arkadyeva N. S. Access to specialist care in small towns: a regional survey // Public Health Perspectives. 2022. Vol. 11, no. 3. P. 201–214.
4. Jovanović M., Petrović S. Digital health literacy among older Europeans // Ageing and Technology. 2021. Vol. 6, no. 1. P. 15–33.
5. Hale R., Moreno C. Barriers to video consultations in rural primary care: a qualitative synthesis // Rural Health Review. 2022. Vol. 14. P. 88–104.
6. Аркадьева Н. С. Телемедицина в системе первичной медико-санитарной помощи: организационные модели // Здравоохранение и общество. 2023. № 2. С. 26–41.
7. Lindholm K., Saar T. Nurse-facilitated telehealth for older patients: a pilot evaluation // Journal of Community Nursing Research. 2020. Vol. 9, no. 4. P. 310–322.
8. Vasilenko O. P. Chronic disease monitoring and remote consultations: early evidence // Digital Health Notes. 2023. Vol. 2. P. 40–52.

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0